

Ekspozycja *wyobrażeniowa*

Drugi filar protokołu PE — kontrolowane przywoływanie wspomnienia traumy w bezpiecznym kontekście. Wspomnienie pamięci sensorycznej przenosi się do narracyjnej. Pełna praca wymaga terapeuty.

CZAS: 30–45 min na sesji terapeutycznej 8–15 sesji w protokole PE

ŹRÓDŁO: Foa, Hembree & Rothbaum (2007, PE)

JAK UŻYWAĆ

Ekspozycja wyobrażeniowa to **wielokrotne, kontrolowane opowiadanie traumy** w terapii — z zamkniętymi oczami, w czasie teraźniejszym, w pierwszej osobie, ze szczegółami zmysłowymi. **Sesja typowo:** 30–45 minut opowiadania, nagrywanego. **Praca domowa:** słuchanie nagrania 1× dziennie między sesjami. **Cykl powtarza się** w trakcie 8–15 sesji terapii. SUDS jest mierzony przed, w trakcie i po. Habitacja zachodzi w *obrębie sesji* (lęk spada w trakcie opowiadania) i *między sesjami* (każdy kolejny tydzień szczyt SUDS jest niższy). **To praca wyłącznie z terapeutą**, nie samodzielnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja wyobrażeniowa pracuje na *pamięci sensorycznej (SAM)*: aktywuje wspomnienie traumy w bezpiecznym kontekście, z dostępną korą przedczołową i hipokampem, co pozwala na **integrację z pamięcią autobiograficzną (VAM)**. Po wystarczającej liczbie powtórzeń wspomnienie zostaje „przeniesione”: z systemu „dzieje się teraz” do systemu „to wydarzenie z mojej historii”. Foa i wsp. (2005) w największym RCT PE wykazali, że **60–80% pacjentów** ukończywszy protokół doświadcza znaczącej redukcji objawów (poniżej progu diagnostycznego), efekt stabilny w 5-letniej obserwacji. To metoda *najlepiej przebadana* w PTSD. Wymaga jednak **specyficznych umiejętności terapeuty** — nieuczone przez ogólne studia psychologiczne. Pacjent powinien upewnić się, że terapeuta jest przeszkolony w PE.

01 Jak wygląda sesja ekspozycji wyobrażeniowej

PRZYGOTOWANIE · 5 MIN

Terapeuta pyta o SUDS przed. Krótka stabilizacja (oddech, ugruntowanie). Włączenie nagrania. Ustalenie znaku, którym pacjent może zatrzymać (zwykle uniesiona ręka).

OPOWIADANIE · 30 MIN

Zamknięte oczy. Czas **teraźniejszy** („*idę przez ulicę... widzę...*”). Pierwsza osoba. Szczegóły zmysłowe — co widzisz, słyszysz, czujesz w ciele, jakie emocje. Co 5 min terapeuta pyta o SUDS. *Pacjent decyduje o tempie*; terapeuta wspiera kontakt z trudnymi fragmentami.

POWTÓRZENIA · 2–3× W SESJI

Ta sama opowieść 2–3 razy. Z każdym powtórzeniem SUDS w obrębie sesji *opada* (habitacja wewnątrzsesyjna). Druga i trzecia opowieść często wnosi nowe szczegóły, których pacjent „nie pamiętał”.

WYCISZENIE · 10 MIN

Powrót do tu i teraz. Otworzenie oczu. Krótkie omówienie. Czas na pytania. Plan tygodnia (słuchanie nagrania 1× dziennie). Terapeuta upewnia się, że pacjent może bezpiecznie wrócić do domu.

02 ☉ Praca domowa między sesjami

SŁUCHANIE NAGRANIA

1 raz dziennie. W spokojnym miejscu. **Bez przewijania.** SUDS przed, po, najwyższy w trakcie. Każde słuchanie obniża szczyt SUDS — to mierzałne.

DZIENNIK SUDS

Tabela: data · SUDS przed · SUDS w trakcie · SUDS po. Po 2–3 tygodniach widać wzorzec spadku. To dowód postępu, gdy emocjonalnie wydaje się, że „nic się nie zmienia”.

EKSPOZYCJA IN VIVO RÓWNOLEGLE

PE łączy obie ekspozycje. Praca z drabiną in vivo idzie równolegle z pracą nad nagraniem — wzmacniają się wzajemnie.

PO SŁUCHANIU

Krótką aktywność powrotną (ugruntowanie, herbata, spacer). Nie planuj słuchania przed snem — może utrudniać zasypianie w pierwszych tygodniach.

03 ✕ Czego unikać przy ekspozycji wyobrażeniowej

SAMODZIELNIE BEZ TERAPEUTY

Ekspozycja wyobrażeniowa *bez przeszkolonego terapeuty* może retraumatyzować. To **praca wyłącznie kliniczna**.

DYSTRAKCJE PODCZAS SŁUCHANIA

Telefon, gotowanie, prowadzenie samochodu — to *blokuje habituację*. Słuchanie wymaga pełnej obecności, jak praca z terapeutą.

ALKOHOL / LEKI PRZED SESJĄ

Wycina habituację (mózg „nie czuje” pełnego materiału). Reguła: 24 godziny abstynencji przed sesją PE i podczas słuchania.

PRZERYWANIE PROTOKOŁU

PE jest najskuteczniejsze przy 8–15 sesjach. Przerwanie po 3–4 sesjach często znaczy, że SUDS rośnie, zanim spadnie. *Przerwa wymaga rozmowy z terapeutą.*

Klucz: ekspozycja wyobrażeniowa jest *najtrudniejszym* elementem terapii PTSD — i dlatego najsilniejszym. To nie metafora ani technika rozluźniająca: to bezpośrednia praca z pamięcią traumatyczną w bezpiecznym kontekście. Pacjenci, którzy ukończą protokół, raportują: „pamiętam, co się stało, ale to teraz historia, nie scena, w której wciąż jestem”. Ta zmiana jest mierzalna w aktywności hipokampa (Lanius 2010) — to nie wrażenie, to neurobiologia.